Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Nonoai

Rua 31 de Maio, 543 - Bairro: Centro - CEP: 99600000 - Fone: (54) 3362-1288 - Balcão Virtual: (54) 9962-1199 - Email: frnonoaivjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001799-80.2023.8.21.0113/RS

AUTOR: MARAIA DOS SANTOS DA SILVA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Trata-se de uma ação cominatória para fornecimento de medicamentos com pedido de tutela de antecipada ajuizada por MARAIA DOS SANTOS DA SILVA, em face do Estado do Rio Grande do Sul. Expôs a necessidade da urgência do fornecimento do medicamento requerido, tendo em vista que o medicamento USTEQUINUMABE é imprescindível para a melhora da autora que é portadora de Doença de Crohn (CID K50.0), Apresentou as especificidades do medicamento solicitado e ressaltou que o autor não dispõe de condições financeiras para a aquisição do fármaco. Requereu liminarmente que fosse determinado ao requerido o fornecimento do medicamento solicito, ou, o depósito judicial de valores suficientes ao custeio e, ao final, a procedência da demanda para confirmar os efeitos da tutela de urgência. Juntou documentos para comprovação (evento 01).

A medida de urgência pleiteada foi deferida, bem como a AJG. (evento 04)

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul, apresentou contestação (evento 14), arguindo, em sede preliminar, a necessidade de inclusão da união no polo passivo da demanda. No mérito, postulou o julgamento de improcedência do feito.

Emenda à inicial (evento 18), tendo sido incluída a união no polo passivo, bem como, pleiteado bloqueio de valores e apresentada réplica à contestação.

Efetuado o bloqueio de valores (evento 28), os autos foram remetidos para a Jutiça Federal (evento 58).

Após a devida tramitação do feito na Justiça Federal, foi determinado, nos autos do agravo de instrumento de 5037981-23.2023.4.04.0000/RS, a remessa novamente do processo para a Justiça Estadual, o que ocorreu no evento 144.

Instadas as partes acerca da produção de outras provas (evento 155), não havendo novos requerimentos.

Juntada de laudo médico atualizado no evento 173.

Parecer final pelo Ministério Público (evento 188).

Vieram os autos conclusos para sentença.

II. Preliminarmente

Trata-se de *ação de fornecimento de medicamento com pedido de tutela de urgência* ajuizada por MARAIA DOS SANTOS DA SILVA em face de ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Alega a parte autora ser portadora Doença de Crohn (CID K50.0), necessitando fazer uso do medicamento USTEQUINUMABE.

Da competência

A questão da competência está superada pela decisão proferida no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234, *in verbis:*

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a ***medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA****,* ***tramitarão perante a Justiça Federal****, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando* ***o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo****, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de* ***Medicamentos*** *(CMED - Lei 10.742/2003),* ***for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos****, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.* ***(Grifei)***

Dessa forma, considerando que houve o ajuizamento do feito em 06/07/2023, data anterior à modulação dos efeitos do **Tema 1234** do **STF**, sendo em 19/09/2024, o feito deverá permanecer na Justiça Estadual.

III. Mérito

Da assistência à saúde

A Constituição Federal, em seu art. 5º[1], caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º[2], que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, o artigo 2º da Lei Federal nº 8.080/90 dispõe que "*a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".*

O dever de conferir máxima eficácia possível aos direitos fundamentais, estes tornam-se direito subjetivo e, havendo omissão estatal na adoção de políticas públicas para o cumprimento de uma prestação em matéria de saúde, possível ao Judiciário determinar, pontualmente, a satisfação do direito, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Contudo, tal direito subjetivo público não deve ser confundido com direito a uma prestação individual ou exclusiva, pois, ainda que satisfeito um conjunto destas prestações, estas não equivalem, pelo seu alcance restrito, atomizado e, sobretudo, individual, à concretização de uma política pública, caracterizada pela amplitude, generalidade e caráter coletivo.

Do Tema 1234 do STF

Em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do **Tema n.º 1234**, foi estabelecido que são considerados **"medicamentos não incorporados"** aqueles que: *(i) não constam nas políticas públicas do SUS; (ii) estão previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) para outras finalidades; (iii) não possuem registro na ANVISA; ou (iv) são utilizados off label, sem previsão em PCDT ou não incluídos nas listas do componente básico.*

A **Súmula Vinculante n.º 60**, que consolida a jurisprudência do **STF** sobre o **Tema 1234**, foi divulgada no Diário Oficial da União, possuindo efeito obrigatório para todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, determinando que "*o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem como seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos três acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no Tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)*."

Neste sentido, o STJ fixou o **Tema Repetitivo nº 106**, em que a tese, para a concessão dos **medicamentos** não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(a) *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

(b) *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*

(c) *existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Passo ao exame das provas, a fim de verificar se preenchidos os pressupostos acima estabelecidos para o atendimento da pretensão da parte autora.

- Quanto ao requisito do **item (a),** comprovado conforme 173 e o laudo juntado à exordial, que discorre sobre todas as especificidades do medicamento, bem como, urgência e imprescindibilidade, por não haverem alternativas para o caso da autora.

- Quanto ao requisito do **item (b)**, comprovado conforme documentos trazidos à exordial, que denotam a baixa renda e hipossuficiência financeira da autora, até pelo elevado preço da medicação.

- Quanto ao requisito do **item (c)**, o medicamento pleitedo nos autos tem registro na ANVISA, conforme n° 1.1236.3394.

- Por sua vez, a Nota Técnica emitida através do Sistema e-NatJus concluiu **favoravelmente** à concessão do tratamento postulado pela parte autora, conforme evento 84, senão, vejamos:

> 6.4 Conclusão técnica: favorável.
>
> 6.5 Justificativa:
>
> Há evidência científica de boa qualidade indicando que o tratamento com ustequinumabe pode resultar em benefício clínico em pacientes com doença de Crohn que apresentaram falha de resposta com uso de agentes biológicos anti-TNF, como o caso em tela.
>
> Além disso, análises econômicas em outros países mostraram que a estratégia de utilizar o ustequinumabe é custo-efetiva. Por fim, a paciente parece ter esgotado as opções terapêuticas disponíveis no SUS.

- Diante disso, tenho que o parecer técnico emitido pelo e-Natjus apresenta evidências científicas que fundamentam a concessão do medicamento. Das justificativas médicas apresentadas, entendo que o não fornecimento do fármaco atentaria diretamente contra o direito constitucional à saúde, ao passo que, devido o impedimento

administrativo, a parte autora sofreria prejuízo significativo na possibilidade de atenuar os efeitos decorrentes de sua enfermidade.

- Portanto, impositiva se torna a procedência do pedido, sendo determinada o fornecimento do medicamento especificado na inicial, podendo se dar por meio da denominação comum brasileira, ** uma vez que não houve especificação quanto à maior eficácia da marca indicada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **MARAIA DOS SANTOS DA SILVA** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** para **CONFIRMAR** a decisão que conferiu a tutela de urgência (EVENTO 04) e **CONDENAR** o réu ao fornecimento do(s) medicamento(s) postulado(s) na inicial, em favor da parte autora ou a disponibilização do equivalente em dinheiro, sob pena de bloqueio de valores, em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação. Para os próximos bloqueios, em sede de Cumprimento de Sentença, a parte autora deverá juntar **orçamento de 3 farmácias**, devendo o valor de venda ser limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na **CONITEC** ou ao valor já praticado pelo ente em compra pública, valendo aquele identificado como menor valor.

- Consigno, que o fornecimento do(s) fármaco(s) deverá perdurar pelo tempo necessário para a realização do tratamento e enquanto o autora e/ou seu grupo familiar não puder prover as despesas com o(s) medicamento(s), sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

- Os **medicamentos** deverão ser **fornecidos pela denominação comum brasileira ou na sua forma comercial**, **o que se mostrar mais vantajoso para o demandado** ou, caso venham a extinguir-se, então **medicamentos similares que contenham o mesmo princípio ativo**, com as advertências do artigo 536, parágrafo 1.º, do novo CPC.

- Fica condicionado o fornecimento do fármaco à apresentação atualizada do receituário médico **semestralmente.**

- Sem reexame necessário (art. 11 da Lei nº 12.153/09).

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se o recorrido para contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, independentemente de conclusão, remeta-se o feito às Turmas Recursais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, forte no artigo 55 da Lei n.° 9.099/95, combinado com o artigo 27 da Lei n.° 12.153/09.

Intimação eletrônica agendada.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **DAVI DE SOUSA LOPES, Juiz de Direito**, em 25/02/2025, às 16:54:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10077327386v6** e o código CRC **dceb3cbd**.

---

1. https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-2-capitulo-1-artigo-5 ↩

2. https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-2-capitulo-2 ↩